EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70296
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-09-05 10:34:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ROSA ELBA MOYA ITURRA			RUN	: 4.131.834-1
F.Nac	: 17-12-1935	Edad	: 87 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LA RIBERA DE UBLE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 91184309		
Fecha Ingreso	: 04-09-2023	Fecha Egreso	: 2023-09-05 10:34:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- HIC parietooccipital mesial izquierdo ICH 2 (Edad y GCS).
- Infección de tracto urinario
- Bicitopenia.
- Antecedente

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- Hipertensión arterial
- Demencia tipo EA Postrada
- ACV isquémicos lacunares silentes
- Artrosis

Antecedentes quirúrgicos:
- Sin antecedentes

Alergias:
- Sin antecedentes de alergia a medicamentos

Medicamentos:
- Losartan 50 mg cadda 12 horas
- Hidralazina 50 mg al día
- Quetiapina 25 mg por ncohe
- Paracetamol 1 gramo cada 12 horas
- Fluoxetina 20 mg al día
- Aspirina 100 mg al día

Diestra mRS 5
Paciente con antecedentes de demencia tipo EA, con mayor deterioro desde el 2020 en relación a infección por SARS CoV2. Posterior a esto, se mantiene en cama, dependiente de actividades básicas de la vida diaria, con alimentación asistida tipo papilla. Con equimosis en extremidades, toráxicas y faciales espontaneas.
Ingresa el 04/09/23 por compromiso de conciencia asociado a crisis generalizadas TC.
Al ingreso se registró en DAU Fc 76 lpm, PA 168/84 mmHg, T° 36, Sat 95%, HGT 84. Se administró lorazepam, al examen somnolencia farmacológica, sin otra descripción al examen neurológico.
Se solicitó estudio complementario con laboratorio en que destacó bicitopenia, y orina inflamatoria con bacterias abundantes. TC de encéfalo sin contraste con hematoma lobar parietooccipital mesial izquierdo sin

vaciamiento. A pesar de funcionalidad se decide hospitalizar para evaluar perfil de presiones arteriales y control de TC, con plan de alta precoz.
Se toma conocimiento formal del caso el 05/09/23 paciente en regulares condiciones generales, posterior al inicio de terapia antihipertensiva con mejor perfil de presiones arteriales, sin eventos de crisis durante hospitalización, sin arritmias en monitorización. Se realizó TC de control a las 12 horas, sin cambios respecto a previo.
Considerando evolución, se decide en conjunto con familia, alta hospitalaria para seguimiento por HODOM.

PLAN DE MANEJO:

Alta con HODOM
Estudio: Realizo IPD descarte
Tratamiento:
- FAE en dosis bajas
- Mantengo tratamiento antibiótico EV
- Aporte bicitopenia, se decide no estudiar por funcionalidad.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo absoluto a 30 grados. Cambios de posición cada 3-4 horas. Iniciar movilización activa en 72 horas
2. Osmolite 250 cc por 3 veces + Agua 200 cc por 3 veces
3. Losartan 50 mg cadda 12 horas, por SNG
4. Hidralazina 50 mg cada 8 horas, por SNG
5. Levetiracetam 500 mg, 1 comp cada 12 horas, por SNG
6. Sertralina 50 mg, 1 comp al día, por SNG
7. Ceftriaxona 1 gramo, 2 Fa al día, EV. Ajustar según urocultivo.
8. Feranim 1 comp cada 12 horas, por SNG
9. Kinesioterapia motora
10. Terapia fonoaudiológica
11. Control solo familiar en CAE en 10 días.
12. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 05/09/23 TC de encéfalo sin contraste: Sin cambios respecto a estudio previo.
- 04/09/23 TC de encefalo sin contraste: Intensa disminución de volumen encefálico a expensas de temporal y frontal. Con microangiopatía. Lesiones de aspecto lacunar capsulares bilaterales. Hematoma lobar parietooccipital mesial izquierdo 5cc sin vaciamiento ventricular.
- 04/09/23 Glic 69, Creat 0.6, MDRD 94.57, Uremia 43, ELP 142/3.4/110, Hb 9.7, Hto 29.4, Leuco 7600, Plaq 73.000, PCR 15.6. P Hepático normal. INR 1.26. Orina inflamatoria.

OBSERVACIONES:

Al examen físico:
SV FC 77 lpm RR, PA 142/70 mmHg, Sat 92 % amb, T° 36.4 °C, HGT 118
- Hidratación adecuada, bien perfundido. con multiples equimosis facial, en extremidades superiores y cara anterior del torax
- RR 2T no ausculto soplos
- MP (+). SRA
- Abdomen: BDI RHA +
- EEII: sin edema, sin signos de TVP, pulsos pedios simétricos

Ex neurológico:
- Mental: sopor profundo, no emite lenguaje ni sigue ordenes.
- PC: pupilas isocoricas, RFM +/+, CV hemianopsia derecha, OCM normal vagabundeo, hipoestesia facial izquierda, PFC izquierda. Resto no evaluable por nivel de conciencia
- Motor: posición en flexión, moviliza menos HC derecho, braquial M2, crural M2. HC izquierdo logra M3
- Sensitivo: hipoestesia BC derecha
- Cerebelo: no evaluable
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO